SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

PACIENTE: Guilherme Holanda
Documento: RAM-PRISMA-0226-NINÁ
Período analisado: 22/02/2026
Fonte primária não estruturada: 5 transcrições de áudio (Demandas maternas)
Fonte dos dados: Sistema REDE (MAD, MAP e RAI) + relatos familiares + observações mediadas
Natureza do documento: Leitura contextual integrada com base em referencial teórico internacional

1. SÍNTESE ACESSÍVEL DO CONJUNTO DOCUMENTAL

O conjunto de áudios analisado revela um momento sensível no percurso socioemocional de Guilherme. As falas maternas indicam preocupação diante de episódios recentes caracterizados por ansiedade antecipatória elevada, frustração intensa frente a pequenas rupturas de expectativa e dificuldade em sustentar experiências sociais inicialmente desejadas.

Observa-se um padrão recorrente: Guilherme demonstra forte desejo de participar de interações sociais e eventos significativos, mas apresenta baixa tolerância à imprevisibilidade inerente a esses contextos. Quando a experiência real diverge do cenário previamente imaginado, ocorre aumento abrupto de ativação emocional, seguido por reações desproporcionais e/ou retraimento.

Do ponto de vista clínico, esse padrão é consistente com o constructo internacionalmente reconhecido de Intolerância à Incerteza (Dugas et al.; South & Rodgers), amplamente descrito na literatura sobre ansiedade em indivíduos no espectro do autismo. A antecipação mental rígida funciona como tentativa de controle. Quando o controle falha, a experiência é vivida como ameaça, não apenas como frustração.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

A análise também indica que não se trata de ausência de desejo social. Ao contrário: há movimento de expansão do interesse relacional. O que se evidencia é um descompasso entre crescimento do desejo de pertencimento e maturidade regulatória disponível para sustentar tal expansão.

Esse ponto é central. O material não sugere regressão estrutural ou agravamento clínico abrupto. Sugere transição desenvolvimental: ampliação do campo social acompanhada de maior sensibilidade emocional.

No plano sistêmico, o discurso materno revela sobrecarga silenciosa. A mãe ocupa posição de reguladora principal do sistema, antecipando crises, tentando organizar o ambiente e buscando compreender racionalmente os eventos. Essa configuração, embora protetiva, pode aumentar o peso emocional concentrado em um único membro da família.

Portanto, o conjunto documental aponta para:

- Intensificação da ansiedade antecipatória;
- Sensibilidade elevada à frustração social;
- Desejo legítimo de pertencimento;
- Déficit momentâneo de ferramentas regulatórias proporcionais;
- Necessidade de redistribuição sistêmica de suporte.

Interpretar este momento exige cuidado: não estamos diante de falhas, mas de crescimento ainda não estruturado.

O **PRISMA**, enquanto ambiente de leitura contextual, indica que o foco não deve ser restringido à redução da crise. O foco deve ser o fortalecimento das competências que permitirão que Guilherme sustente a expansão que ele próprio já começou a buscar.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

2. CONTEXTOS IDENTIFICADOS

A compreensão adequada do conjunto documental exige que os episódios relatados não sejam analisados de forma isolada, mas situados dentro de seus contextos temporais, sociais, emocionais e sistêmicos. O PRISMA opera justamente nesse ponto: desloca o foco do evento para o campo relacional em que o evento se insere.

2.1 Contexto Temporal: Momento Desenvolvimental

Os registros indicam que Guilherme encontra-se em fase de ampliação de experiências sociais, com maior exposição a eventos coletivos e dinâmicas relacionais complexas. Esse movimento é coerente com etapas de desenvolvimento em que o desejo de pertencimento se intensifica (Steinberg, Desenvolvimento Adolescente; Blakemore, Social Brain Development).

A ampliação do campo social aumenta, simultaneamente:

- A quantidade de variáveis imprevisíveis;
- A complexidade das interações;
- A necessidade de leitura implícita de sinais sociais;
- A exposição à comparação e avaliação social.

Em indivíduos com perfil de rigidez cognitiva e maior necessidade de previsibilidade, essa expansão pode gerar sobrecarga regulatória. Portanto, o contexto temporal não é neutro: ele é um fator amplificador da vulnerabilidade à ansiedade.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

2.2 Contexto Social: Ambientes de Alta Variabilidade

Os episódios descritos envolvem situações com:

- Expectativas sociais prévias;
- Interações múltiplas e simultâneas;
- Potencial de mudança rápida de planos;
- Elementos de imprevisibilidade relacional.

A literatura internacional sobre ansiedade social e TEA (White et al., 2009; Bellini, 2006) destaca que ambientes socialmente densos exigem:

- Flexibilidade cognitiva;
- Processamento rápido de pistas sociais;
- Regulação emocional em tempo real;
- Tolerância à ambiguidade.

Quando essas habilidades ainda estão em desenvolvimento, o ambiente passa a funcionar como fator de estresse, mesmo quando o desejo de participação está presente.

Importante destacar: o estresse não decorre da socialização em si, mas da imprevisibilidade que a acompanha.

2.3 Contexto Cognitivo: Antecipação como Estratégia de Controle

Os registros sugerem forte presença de antecipação mental estruturada. Guilherme parece construir cenários prévios relativamente fechados sobre como o evento ocorrerá.

Essa estratégia é compreendida, na literatura cognitiva (Beck; Dugas; Clark & Beck), como tentativa adaptativa de reduzir incerteza. Contudo, quando a antecipação se torna rígida, ela aumenta a discrepância entre expectativa e realidade.

Assim, forma-se o ciclo:

1. Construção mental do cenário ideal;
2. Investimento emocional na previsão;
3. Ruptura da expectativa;
4. Interpretação da ruptura como ameaça;
5. Desregulação emocional.

O contexto cognitivo, portanto, já predispõe à amplificação da frustração.

2.4 Contexto Emocional: Sensibilidade à Rejeição Implícita

Ainda que não haja evidências objetivas de rejeição explícita, os relatos sugerem sensibilidade aumentada à possibilidade de exclusão e/ou frustração social.

A literatura sobre Rejection Sensitivity (Downey & Feldman) indica que indivíduos com histórico de dificuldades sociais podem desenvolver hiperatenção a sinais ambíguos de rejeição. Mesmo pequenas mudanças — atraso, alteração de plano, menor reciprocidade — podem ser interpretadas como confirmação de não pertencimento.Esse dado é relevante porque desloca a análise do comportamento externo para a experiência subjetiva interna.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

2.5 Contexto Sistêmico-Familiar

No plano familiar, observa-se:

- Forte envolvimento materno na organização emocional;
- Monitoramento constante de possíveis crises;
- Movimento preventivo contínuo.

Segundo Bowen, sistemas familiares sob estresse tendem a aumentar a fusão emocional. A mãe, ao assumir posição central de regulação, protege o sistema no curto prazo, mas pode, inadvertidamente, reduzir oportunidades de desenvolvimento autônomo de autorregulação.

Importante frisar: não se trata de erro parental, mas de adaptação funcional diante da vulnerabilidade percebida.

2.6 Conexões com Módulos do Sistema REDE

O cruzamento com registros anteriores aponta recorrência de:

- Ansiedade pré-evento;
- Frustração pós-ruptura de expectativa;
- Ambivalência entre desejo e evitação;
- Intensificação emocional em eventos festivos.

O contexto atual não é isolado; ele integra um padrão longitudinal. No entanto, há um elemento novo: aumento do desejo social concomitante à manutenção da fragilidade regulatória.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

2.7 Síntese Contextual

Os episódios relatados não devem ser interpretados como falhas pontuais de comportamento. Eles emergem da interseção entre:

- Expansão desenvolvimental;
- Ambientes socialmente variáveis;
- Rigidez antecipatória;
- Sensibilidade à rejeição implícita;
- Sistema familiar altamente protetivo.

O contexto, portanto, não explica apenas o evento — ele o estrutura.

No PRISMA, compreender contexto é compreender campo de forças. E o campo atual indica um momento de transição, onde crescimento e vulnerabilidade coexistem.

3. LEITURA INTERPRETATIVA MULTIDISCIPLINAR

A leitura multidisciplinar no PRISMA não consiste em sobrepor teorias, mas em articular lentes complementares que permitam compreender o fenômeno em sua complexidade. O objetivo não é rotular o comportamento, mas compreender os mecanismos que o sustentam, para que a intervenção seja precisa, proporcional e sensível.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

O conjunto documental foi analisado a partir de quatro eixos teóricos internacionais: neurodesenvolvimental, cognitivo-comportamental, regulação emocional e sistêmico-familiar.

3.1 Perspectiva Neurodesenvolvimental

Referenciais:

- American Psychiatric Association (DSM-5-TR);
- Baron-Cohen (Teoria da Mente);
- Pellicano & Burr (Intolerance of Uncertainty);
- South & Rodgers (Anxiety in ASD);
- Mazefsky et al. (Emotion Dysregulation in Autism).

A literatura contemporânea demonstra que a ansiedade em indivíduos no espectro frequentemente está menos associada a medo objetivo e mais relacionada à intolerância à incerteza (IU). A IU é definida como dificuldade persistente em lidar com situações ambíguas ou imprevisíveis, levando a esforço cognitivo excessivo para prever e controlar resultados.

Nos registros analisados, observa-se:

- Construção antecipatória detalhada de cenários;
- Elevação emocional antes do evento ocorrer;
- Desregulação após ruptura de expectativa.

Esse padrão é consistente com o modelo de IU como mediador central da ansiedade. A antecipação rígida atua como mecanismo compensatório: quanto maior a necessidade de previsibilidade, maior o investimento na

construção de um roteiro mental. Quando esse roteiro não se confirma, a experiência é vivida como perda de controle.

Do ponto de vista neurobiológico, estudos indicam maior reatividade da amígdala e menor modulação pré-frontal em situações de ambiguidade em indivíduos com ansiedade associada ao TEA (Herrington et al., 2017). Isso ajuda a compreender por que a resposta emocional pode parecer desproporcional ao evento objetivo.

Importante: a intensidade da reação não indica fragilidade moral ou imaturidade voluntária, mas um sistema de processamento sensível à incerteza.

3.2 Perspectiva Cognitivo-Comportamental

Referenciais:

- Beck (Modelo Cognitivo);
- Clark & Beck (Anxiety Disorders);
- Barlow (Modelo Transdiagnóstico);
- Dugas & Robichaud (Generalized Anxiety Model).

Sob a lente cognitiva, os episódios podem ser compreendidos como resultado de interpretações automáticas diante de discrepâncias entre expectativa e realidade.

Possíveis distorções identificáveis no padrão relatado:

- Catastrofização: pequena frustração interpretada como grande perda;
- Pensamento dicotômico: “ou foi como imaginei ou foi ruim”;

- Personalização: mudança externa percebida como falha pessoal;
- Generalização: evento isolado ampliado para padrão global.

Esses processos não ocorrem de forma deliberada. São respostas automáticas aprendidas ao longo da experiência de vulnerabilidade social.

O modelo transdiagnóstico de Barlow sugere que a evitação posterior é reforçada negativamente: ao evitar nova exposição, reduz-se a ansiedade momentaneamente, fortalecendo o ciclo de medo.

Assim, o risco não está no evento isolado, mas na consolidação do padrão antecipação → frustração → evitação.

3.3 Perspectiva da Regulação Emocional

Referenciais:

- Gross (Process Model of Emotion Regulation);
- Mazefsky et al.;
- DBT Skills Framework.

Segundo o modelo de Gross, a regulação emocional pode ocorrer em diferentes etapas: seleção da situação, modificação da situação, direcionamento da atenção, mudança cognitiva e modulação da resposta.

Nos registros, observa-se que Guilherme tende a:

- Investir fortemente na etapa de seleção (escolher participar);
- Tentar modificar antecipadamente a situação via planejamento mental;
- Ter dificuldade na mudança cognitiva após a frustração;

- Apresentar resposta emocional intensa quando a modulação falha.

Isso sugere que as habilidades iniciais de engajamento estão presentes, mas as habilidades tardias de reavaliação cognitiva ainda estão em desenvolvimento.

Esse dado é fundamental: há competência para desejar e iniciar experiências, mas fragilidade para sustentar o imprevisto.

3.4 Perspectiva Sistêmico-Familiar

Referenciais:

- Bowen (Family Systems Theory);
- Minuchin (Structural Family Therapy);
- Mikolajczak et al. (Parental Burnout).

No plano sistêmico, observa-se uma mãe altamente engajada na leitura e organização emocional do filho. Esse movimento é protetivo e adaptativo, sobretudo diante do histórico de crises.

Entretanto, sistemas sob estresse tendem a aumentar centralização regulatória. Quando um membro assume posição predominante de estabilização emocional, pode ocorrer:

- Sobrecarga progressiva;
- Redução de oportunidades de autonomia regulatória;
- Hiperfoco preventivo no risco.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

A fala materna demonstra busca ativa por compreensão técnica, o que é um fator de proteção. Contudo, também revela desgaste implícito.

O sistema familiar, portanto, encontra-se funcional, porém tensionado.

3.5 Integração Multidisciplinar

A convergência das lentes aponta para um eixo central:

Há expansão legítima do desejo social coexistindo com intolerância à incerteza e habilidades regulatórias ainda insuficientes para sustentar essa expansão. O fenômeno não é regressão. É crescimento com sobrecarga.

O ponto clínico sensível é evitar que a ansiedade secundária transforme expansão em retração. O ponto sistêmico sensível é evitar que a proteção se transforme em hiperresponsabilização exclusiva.

3.6 Síntese Interpretativa

A leitura multidisciplinar indica que:

- O comportamento observado é coerente com modelos internacionais de ansiedade associada à imprevisibilidade;
- O padrão cognitivo reforça a intensidade emocional;
- A regulação ainda depende fortemente de mediação externa;
- O sistema familiar atua como amortecedor, mas com risco de sobrecarga.

Portanto, a intervenção deve focar menos na supressão do sintoma e mais no fortalecimento das competências estruturais que permitirão sustentar o movimento de expansão em curso.

4. DADOS DE TRIGGERS IDENTIFICADOS (Análise Estrutural de Gatilhos e Padrões Longitudinais)

No PRISMA, “trigger” não é entendido como causa isolada, mas como ponto de ativação dentro de um campo mais amplo de vulnerabilidades e expectativas. O gatilho não explica o fenômeno sozinho; ele apenas revela onde o sistema já se encontrava sensível.

A análise das transcrições, em cruzamento com registros prévios do Sistema REDE, permite identificar padrões consistentes de ativação emocional.

4.1 Estrutura Geral dos Triggers Observados

Os episódios relatados seguem uma sequência relativamente previsível:

1. Construção antecipatória intensa;
2. Elevação progressiva da ativação emocional;
3. Evento com variável imprevisível;
4. Ruptura da expectativa;
5. Desregulação emocional;

6. Tendência à retração ou evitação subsequente.

Esse encadeamento indica que o gatilho não está apenas no evento externo, mas na discrepância entre o cenário mental construído e a realidade vivida.

4.2 Triggers Primários Identificados

1. Ruptura de Expectativa Social

Base teórica:

- Intolerance of Uncertainty Model (Dugas);
- Predictive Coding Models (Friston);
- South & Rodgers (ASD and Anxiety).

A quebra de roteiro previamente imaginado emerge como gatilho nuclear. A antecipação funciona como tentativa de reduzir incerteza; quando o evento diverge, a discrepância gera sobrecarga.

O sistema cognitivo, que investiu fortemente na previsão, interpreta a diferença como perda de controle.

2. Ambiguidade Relacional

Base teórica:

- Rejection Sensitivity (Downey & Feldman);
- Social Information Processing Theory.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

Mudanças sutis — atraso, resposta menos entusiasmada, alteração de plano — podem ser interpretadas como rejeição implícita.

Mesmo na ausência de evidência objetiva de exclusão, a ambiguidade pode ser vivida como ameaça ao pertencimento.

3. Perda de Controle Situacional

Base teórica:

- Perceived Control Theory (Chorpita & Barlow);
- Learned Helplessness (Seligman).

Ambientes onde múltiplas variáveis fogem ao planejamento prévio aumentam a sensação de vulnerabilidade. Quanto maior o investimento antecipatório, maior a sensação de desorganização quando o controle se rompe.

4. Exposição Social Prolongada

Base teórica:

- Social Fatigue in Autism Research;
- Cognitive Load Theory (Sweller).

Eventos com múltiplos estímulos sociais exigem processamento contínuo de pistas verbais e não verbais. A sobrecarga cognitiva pode reduzir a capacidade de reavaliação emocional no momento crítico.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

4.3 Trigger Nuclear: Discrepância entre Cenário Antecipado e Realidade

Ao integrar os dados, observa-se que o verdadeiro gatilho não é o evento específico, mas a discrepância percebida.

Esse dado é fundamental para a intervenção. Se o foco for apenas “evitar situações sociais”, o sistema aprende que o problema é o ambiente. Se o foco for ampliar tolerância à discrepância, o sistema aprende que pode sobreviver à diferença.

4.4 Padrão Longitudinal no Sistema REDE

O cruzamento com registros anteriores revela recorrência de:

- Ansiedade pré-evento festivo;
- Ambivalência (querer participar × medo de frustração);
- Intensificação emocional após mudanças inesperadas;
- Recuperação gradual quando há mediação externa estruturada.

Contudo, há um elemento evolutivo importante: O desejo social parece mais forte do que em registros mais antigos.

Isso indica crescimento no eixo motivacional, mesmo que o eixo regulatório ainda esteja em consolidação.

4.5 Fatores Protetivos Identificados

Apesar dos triggers, o sistema apresenta fatores de proteção relevantes:

- Capacidade verbal de expressão posterior;
- Presença de adulto regulador disponível;
- Busca ativa da mãe por compreensão técnica;
- Histórico de recuperação após crise.

Esses fatores reduzem o risco de cristalização patológica.

4.6 Leitura Integrada de Risco

Risco principal não é a crise isolada. O risco estrutural é o reforço do ciclo de evitação.

Modelo potencial: Antecipação → Frustração → Sofrimento → Evitação → Alívio temporário → Reforço da evitação.

Intervenções devem interromper esse ciclo antes que ele se consolide como padrão dominante.

4.7 Síntese Estrutural dos Triggers

O conjunto documental aponta para um sistema altamente sensível à imprevisibilidade social, com:

- Elevado investimento antecipatório;
- Baixa tolerância à discrepância;
- Sensibilidade à ambiguidade relacional;

- Vulnerabilidade à sobrecarga cognitiva.

Ao mesmo tempo, observa-se:

- Desejo autêntico de pertencimento;
- Sistema familiar responsivo;
- Capacidade de aprendizado em curso.

O PRISMA identifica, portanto, um ponto de inflexão: A expansão social está pressionando os limites atuais de regulação.

5. ACHADOS PRISMA (Construção Progressiva de Sentido – Formulação Integrada)

No PRISMA, os **achados** não são conclusões fechadas, mas pontos de convergência entre registros, teorias e contexto. Eles representam aquilo que emerge de forma consistente quando o conjunto de dados é observado de maneira transversal e longitudinal.

Os achados abaixo resultam da integração entre transcrições, histórico do Sistema REDE, leitura contextual e referenciais teóricos internacionais.

Achado 1 — Intensificação da Ansiedade Antecipatória

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

Há evidências consistentes de aumento da ansiedade antes de eventos sociais. Esse aumento não se manifesta apenas como nervosismo, mas como investimento cognitivo elevado na tentativa de prever e/ou controlar o desenrolar da situação.

Referenciais:

- Dugas & Robichaud (Intolerance of Uncertainty);
- Barlow (Transdiagnostic Model of Anxiety).

Interpretação: A antecipação funciona como estratégia adaptativa de redução de incerteza. Contudo, quando excessiva e rígida, ela eleva o custo emocional da experiência. O sofrimento começa antes do evento ocorrer.

Implicação clínica: Intervenções precisam atuar no **pré-evento**, não apenas no manejo da crise.

Achado 2 — Baixa Tolerância à Discrepância entre Expectativa e Realidade

Os registros indicam dificuldade significativa em lidar com pequenas variações do cenário antecipado. Mesmo mudanças consideradas menores podem desencadear resposta emocional intensa.

Referenciais:

- Predictive Processing (Friston);
- Cognitive Flexibility Research (Miyake et al.).

Interpretação: O sistema cognitivo opera com modelos mentais relativamente fechados. A realidade divergente é interpretada como erro crítico, não como variação tolerável.

Implicação clínica: É necessário treinar **flexibilidade cognitiva aplicada**, com exposição gradual à diferença.

Achado 3 — Conflito entre Desejo de Pertencimento e Medo de Frustração

Um dos achados centrais do PRISMA é a coexistência de dois movimentos aparentemente opostos:

- Desejo genuíno de participação social;
- Medo intenso de se frustrar ou se sentir deslocado.

Referenciais:

- Social Motivation Theory (Chevallier et al.);
- Anxiety and Avoidance Models.

Interpretação: O desejo social não está ausente; ele está em expansão. O sofrimento surge quando o sistema regulatório não acompanha essa expansão.

Implicação clínica: Reduzir exposição social indiscriminadamente pode gerar alívio imediato, mas prejudica o desenvolvimento a médio prazo.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

Achado 4 — Desregulação Emocional como Resposta Secundária

As reações intensas observadas não são o problema primário, mas uma resposta secundária à sobrecarga cognitiva e emocional.

Referenciais:

- Gross (Emotion Regulation);
- Mazefsky et al. (Emotion Dysregulation in ASD).

Interpretação: Quando a reavaliação cognitiva falha, a emoção “escapa” em forma de reação. Isso não indica falta de vontade de se regular, mas ausência de ferramentas suficientes naquele momento.

Implicação clínica: Ensinar regulação emocional explícita é mais eficaz do que exigir autocontrole abstrato.

Achado 5 — Sistema Familiar como Amortecedor e Fator de Risco

O sistema familiar, especialmente a figura materna, atua como forte fator de proteção, oferecendo contenção, mediação e busca ativa por compreensão.

Referenciais:

- Bowen (Family Systems);
- Mikolajczak (Parental Burnout).

Interpretação: A centralização da regulação em um único membro protege no curto prazo, mas pode gerar sobrecarga e limitar o desenvolvimento de autonomia emocional.

Implicação clínica: A intervenção deve incluir o sistema, não apenas o indivíduo.

Achado 6 — Momento Desenvolvimental de Transição

O conjunto de dados não aponta para regressão clínica, mas para um momento de transição. O aumento da complexidade social expôs limites regulatórios que antes não eram tão exigidos.

Referenciais:

- Developmental Transitions (Steinberg; Blakemore).

Interpretação: O sofrimento não indica falha do processo, mas sinaliza crescimento em curso.

Implicação clínica: Este é um ponto estratégico de intervenção: ou o sistema amplia repertório regulatório, ou cristaliza padrões evitativos.

Síntese dos Achados PRISMA

Integrando os achados, o PRISMA aponta para um eixo central:

> Guilherme está ampliando seu campo social e emocional, mas ainda não dispõe de ferramentas regulatórias suficientes para sustentar a imprevisibilidade inerente a essa expansão.

O risco não é a crise pontual. O risco é interromper o movimento de crescimento por medo da crise. Ao mesmo tempo, o sistema apresenta recursos importantes: vínculo familiar forte, capacidade reflexiva e busca ativa por apoio.

Esses elementos tornam o momento atual especialmente fértil para intervenção estruturada.

6. ANÁLISE DE RISCO (Dimensão Clínica, Desenvolvimental e Sistêmica)

Com o PRISMA, análise de risco não se limita à identificação de perigo imediato. Trata-se de compreender trajetórias possíveis: quais caminhos tendem a se consolidar caso o padrão atual permaneça inalterado e quais caminhos podem emergir caso haja intervenção estruturada.

A análise a seguir integra literatura internacional, histórico longitudinal do Sistema REDE e dados recentes das transcrições.

6.1 Risco Clínico de Curto Prazo

Intensificação de episódios de desregulação

Referenciais:

- Barlow (Emotional Disorders Model);
- Mazefsky et al. (Emotion Dysregulation in ASD).

Se o ciclo de antecipação rígida → frustração → explosão emocional não for interrompido, há probabilidade de aumento da frequência ou intensidade das crises.

Contudo, com base nos registros atuais, não há indicativo de desorganização estrutural grave, ideação autolesiva e/ou perda global de funcionamento. O risco imediato é moderado e circunscrito à desregulação episódica.

6.2 Risco Desenvolvimental de Médio Prazo

Consolidação de Evitação Social

Referenciais:

- Barlow (Avoidance Reinforcement Cycle);
- Clark & Beck (Anxiety Disorders);
- White et al. (Anxiety in ASD).

O maior risco identificado é a cristalização do ciclo de evitação:

1. Antecipação ansiosa;
2. Frustração;
3. Sofrimento;
4. Evitação futura;
5. Alívio momentâneo;
6. Reforço da evitação.

Se esse padrão se estabiliza, pode ocorrer:

- Redução gradual da exposição social;
- Empobrecimento de repertório relacional;
- Aumento de ansiedade antecipatória ao longo do tempo.

Esse é o risco estrutural mais relevante no momento atual.

6.3 Risco Cognitivo

Rigidez Interpretativa Progressiva

Referenciais:

- Beck (Cognitive Model);
- Cognitive Flexibility Research.

Sem intervenção, pequenas frustrações podem ser progressivamente interpretadas como evidências confirmatórias de incapacidade ou exclusão.

Isso pode levar a:

- Generalizações negativas;
- Redução da tolerância à ambiguidade;
- Ampliação de pensamento dicotômico.

A médio prazo, isso impacta a autoestima e a autoconfiança social.

6.4 Risco Emocional

Sensibilidade Ampliada à Rejeição

Referenciais:

- Rejection Sensitivity Theory;
- Social Anxiety Models.

Se episódios ambíguos continuarem sendo interpretados como rejeição implícita, pode ocorrer aumento da hipervigilância social.

A hipervigilância eleva a carga cognitiva durante interações, o que, por sua vez, aumenta a probabilidade de nova desregulação. Forma-se um ciclo de amplificação.

6.5 Risco Sistêmico-Familiar

Sobrecarga Regulatória Materna

Referenciais:

- Bowen (Family Systems);
- Mikolajczak et al. (Parental Burnout).

O sistema familiar encontra-se funcional, mas com tendência à centralização regulatória na figura materna. Sem redistribuição progressiva de responsabilidades e/ou sem espaços de sustentação para a mãe, há risco de:

- Exaustão emocional;
- Aumento de vigilância preventiva;
- Redução da tolerância sistêmica ao erro.

Isso pode, inadvertidamente, aumentar a percepção de fragilidade do sistema como um todo.

6.6 Fatores Protetivos Relevantes

A análise de risco deve sempre considerar fatores de proteção.

Identificados:

- Forte vínculo familiar;
- Capacidade de reflexão posterior sobre eventos;
- Ausência de retraimento social consolidado;
- Busca ativa por orientação técnica;
- Histórico de recuperação após crises.

Esses elementos reduzem significativamente o risco de evolução para quadros mais graves.

6.7 Leitura Integrada de Risco

O momento atual não configura risco agudo elevado.

Configura, sim, um **ponto sensível de bifurcação desenvolvimental**:

- Caminho A: Evitação progressiva e rigidez crescente;
- Caminho B: Ampliação de repertório regulatório e consolidação de autonomia emocional.

A diferença entre esses caminhos dependerá da qualidade e consistência da intervenção aplicada nos próximos meses.

O PRISMA identifica este momento como janela estratégica de desenvolvimento.

6.8 Síntese da Análise de Risco

O risco principal não está na intensidade da última crise. Está na possibilidade de que o sistema aprenda que evitar é mais seguro do que enfrentar.

Ao mesmo tempo, o cenário apresenta recursos suficientes para que o caminho de crescimento seja favorecido.

A presença de sofrimento aqui não é sinal de falência. É sinal de transição.

7. HIPÓTESE INTEGRADA PRISMA (Formulação Clínica Final e Direcionamento Estratégico)

A Hipótese Integrada PRISMA não é um diagnóstico, mas uma formulação dinâmica que organiza os dados em um modelo explicativo coerente, articulando indivíduo, contexto e sistema.

Ela responde à pergunta central: O que está realmente acontecendo no sistema neste momento?

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

7.1 Formulação Nuclear

A análise integrada indica que Guilherme encontra-se em um momento de expansão motivacional social que ultrapassa, temporariamente, sua capacidade regulatória disponível.

Em termos sintéticos: O desejo de pertencimento está crescendo mais rápido do que as ferramentas emocionais para sustentar a imprevisibilidade que o pertencimento exige.

Essa discrepância gera:

- Ansiedade antecipatória elevada;
- Investimento cognitivo rígido em previsibilidade;
- Sofrimento intenso diante de pequenas rupturas;
- Risco de evitação como estratégia de autoproteção.

7.2 Modelo Integrado do Funcionamento Atual

Com base nos referenciais internacionais analisados, o funcionamento atual pode ser descrito da seguinte forma:

1. Motivação social aumentada (Social Motivation Theory);
2. Intolerância à incerteza elevada (Dugas; South & Rodgers);
3. Rigidez cognitiva moderada (Executive Function Research);
4. Estratégias regulatórias ainda imaturas (Gross; Mazefsky);
5. Sistema familiar altamente protetivo (Bowen).

Esses elementos, combinados, produzem um sistema sensível, porém plástico. Não há indicativo de retraimento estrutural consolidado. Há tensão entre crescimento e capacidade de sustentação.

7.3 O Significado do Sofrimento Atual

É fundamental reinterpretar o sofrimento observado. Sob uma lente restritiva, ele poderia ser lido como fragilidade. Sob a lente desenvolvimental, ele é sinal de expansão. O desconforto emerge porque o campo de experiência ampliou-se.

Guilherme está tentando habitar espaços mais complexos — emocional e socialmente. A dor aparece quando a complexidade supera a ferramenta disponível. Isso é típico de transições desenvolvimentais.

7.4 Risco Estrutural Identificado

O maior risco não é a intensidade emocional. É a aprendizagem implícita que pode derivar dela.

Se o sistema concluir que: “Sentir isso é insuportável” ou “É melhor não tentar novamente” então o caminho de retração ganha força.

Se, ao contrário, o sistema aprender que: “Posso sentir isso e sobreviver” e “Posso ajustar expectativas e continuar tentando” então o episódio se transforma em consolidação de maturidade.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

7.5 Direcionamento Estratégico Derivado da Hipótese

A intervenção, portanto, não deve buscar:

- Eliminar totalmente a ansiedade;
- Controlar rigidamente todos os contextos;
- Reduzir drasticamente a exposição social.

Ela deve buscar:

- Aumentar tolerância à discrepância;
- Ensinar regulação emocional explícita;
- Manter exposição social graduada;
- Redistribuir responsabilidade regulatória no sistema.

O foco deixa de ser “evitar crise” e passa a ser “construir competência”.

7.6 Formulação Final PRISMA

O momento atual pode ser sintetizado da seguinte forma:

Guilherme está em processo de ampliação de seu campo social e emocional. A ansiedade observada não é sinal de regressão, mas de expansão ainda não consolidada. O sistema familiar atua como fator de proteção robusto, porém necessita redistribuir cargas regulatórias para evitar sobrecarga. A janela atual é estratégica: com intervenção adequada, o sofrimento pode se converter em maturidade regulatória.

7.7 Enquadramento Ético-Desenvolvimental

Este Manual propõe uma leitura que evita dois extremos:

- Patologizar o crescimento;
- Minimizar o sofrimento.

Ambos são reais: há crescimento e há dor. A função clínica é sustentar o crescimento enquanto ensina ferramentas para atravessar a dor.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E DIRETRIZES PARA PROFISSIONAIS E FAMILIARES

O conjunto de dados analisado por meio do PRISMA revela um momento sensível e, ao mesmo tempo, promissor no desenvolvimento de Guilherme. O sofrimento observado não deve ser compreendido como regressão ou falha estrutural, mas como manifestação de um sistema que está se expandindo além de sua zona anterior de conforto.

Este é um ponto central deste Manual: Crescimento emocional frequentemente antecede estabilidade emocional.

A ampliação do desejo de pertencimento social trouxe consigo maior exposição à imprevisibilidade. A imprevisibilidade, por sua vez, ativou vulnerabilidades já conhecidas — intolerância à incerteza, rigidez antecipatória e dificuldade de reavaliação cognitiva em tempo real.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

O momento atual exige equilíbrio fino entre proteção e promoção de autonomia.

8.1 Para Profissionais

1. **Evitar intervenções centradas apenas na redução de crise.** O foco deve ser estrutural: fortalecimento de habilidades regulatórias e tolerância à discrepância.
2. **Intervir no pré-evento.** A ansiedade antecipatória é o ponto de maior custo emocional. Estratégias cognitivas e de regulação devem ser aplicadas antes da exposição.
3. **Manter exposição social graduada.** A retirada excessiva de contextos sociais pode consolidar a evitação.
4. **Trabalhar flexibilidade cognitiva aplicada.** Exercícios abstratos têm pouco efeito se não forem vinculados a experiências reais.
5. **Incluir o sistema familiar na intervenção.** A regulação não deve permanecer concentrada em um único membro.

8.2 Para Familiares

1. **Compreender que a intensidade emocional não é desobediência nem fragilidade voluntária.** Trata-se de um sistema sensível à imprevisibilidade.
2. **Evitar eliminar todas as incertezas do ambiente.** A meta não é construir um mundo sem frustração, mas ensinar o atravessamento da frustração.

3. **Separar evento de identidade.** Uma experiência difícil não define capacidade global.
4. **Validar emoção sem validar catastrofização.** “Entendo que foi difícil” é diferente de “realmente foi insuportável”.
5. **Cuidar da saúde emocional do cuidador.** A sustentação familiar depende da sustentação interna de quem regula.

8.3 O Papel do Sistema REDE neste Momento

O Sistema REDE, por meio do PRISMA e do RAM, atua como organizador de sentido. Ele impede que eventos isolados sejam interpretados como rupturas definitivas e os reinsere em uma narrativa longitudinal.

Ao conectar registros, teorias e contextos, o PRISMA transforma episódios em aprendizado possível. Este Manual não propõe eliminar o sofrimento. Propõe transformá-lo em competência.

8.4 Síntese Final

O momento atual é uma janela desenvolvimental.

Há sofrimento real. Há risco moderado de cristalização evitativa. Há forte presença de fatores protetivos. Há desejo legítimo de crescimento.

Com intervenção consistente, o cenário mais provável não é retração — é amadurecimento regulatório.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

O objetivo não é que Guilherme deixe de sentir ansiedade. O objetivo é que ele aprenda que pode senti-la e continuar caminhando.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

ANEXO A: VERSÃO EXECUTIVA SINTÉTICA

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Este RAM tem como finalidade organizar, de forma técnica e integrada, a análise das demandas maternas referentes a episódios recentes envolvendo ansiedade antecipatória, frustração social e desregulação emocional de Guilherme.

O documento baseia-se em referenciais teóricos de reconhecimento internacional nas áreas de:

- Ansiedade e Intolerância à Incerteza;
- Regulação Emocional;
- Flexibilidade Cognitiva;
- Desenvolvimento Socioemocional;
- Teoria Sistêmica Familiar.

2. SÍNTESE CLÍNICA DO MOMENTO ATUAL

Os registros indicam:

- Intensificação da ansiedade antes de eventos sociais;
- Elevado investimento cognitivo na antecipação de cenários;
- Sofrimento significativo quando há ruptura de expectativa;
- Reações emocionais desproporcionais à variação objetiva do evento;

- Tendência subsequente à retração ou evitação.

Contudo, observa-se também:

- Desejo genuíno de pertencimento social;
- Motivação para participar de eventos;
- Capacidade posterior de reflexão;
- Forte sustentação familiar.

A análise sugere que o sofrimento atual não representa regressão estrutural, mas um momento de expansão social que ultrapassa, temporariamente, a capacidade regulatória disponível.

3. FORMULAÇÃO CLÍNICA INTEGRADA

A leitura multidisciplinar aponta para o seguinte modelo explicativo:

3.1 Eixo Central

Expansão do desejo social coexistindo com intolerância elevada à imprevisibilidade.

3.2 Mecanismo Predominante

1. Antecipação rígida como tentativa de controle;
2. Investimento emocional no cenário previsto;
3. Ruptura da expectativa;
4. Interpretação da discrepância como ameaça;

5. Desregulação emocional.

Esse padrão é consistente com o modelo de **Intolerância à Incerteza** (Dugas; South & Rodgers) amplamente descrito em quadros de ansiedade associados ao TEA.

4. PRINCIPAIS TRIGGERS IDENTIFICADOS

- Ruptura de expectativa social;
- Ambiguidade relacional;
- Perda de controle situacional;
- Ambientes de alta variabilidade social;
- Exposição social prolongada com elevada carga cognitiva.

O trigger nuclear identificado é a discrepância entre o cenário antecipado e a realidade vivida.

5. ANÁLISE DE RISCO

5.1 Curto Prazo

- Episódios de desregulação emocional episódica;
- Sofrimento intenso, porém circunscrito.

5.2 Médio Prazo (Risco Estrutural Principal)

- Consolidação de padrão evitativo;
- Redução progressiva da exposição social;
- Rigidez interpretativa crescente.

5.3 Sistêmico

- Sobrecarga regulatória concentrada na figura materna.

Importante: Não há indícios atuais de risco psiquiátrico grave ou desorganização global do funcionamento.

6. FATORES PROTETIVOS

- Forte vínculo familiar;
- Busca ativa por orientação técnica;
- Capacidade verbal de elaboração posterior;
- Desejo de pertencimento social preservado;
- Histórico de recuperação após crises.

Esses fatores reduzem significativamente o risco de evolução negativa.

7. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

A intervenção deve priorizar:

7.1 Tolerância à Incerteza

- Treino gradual de exposição à imprevisibilidade;
- Técnica Plano A / Plano B / Plano C;
- Trabalho pré-evento estruturado.

7.2 Regulação Emocional

- Identificação explícita de emoções;
- Escala subjetiva de ativação;
- Técnicas fisiológicas de modulação.

7.3 Flexibilidade Cognitiva

- Reestruturação cognitiva aplicada a eventos reais;
- Exercícios de múltiplas interpretações possíveis.

7.4 Manutenção de Exposição Social

- Eventos com duração ajustada;
- Saídas estruturadas (não fuga impulsiva);
- Debrief pós-evento.

7.5 Sustentação Sistêmica

- Redistribuição gradual da responsabilidade regulatória;
- Espaço de escuta estruturado para cuidadores;
- Prevenção de sobrecarga parental.

8. HIPÓTESE FINAL PRISMA

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)

Guilherme encontra-se em momento de ampliação do campo social e emocional. A ansiedade observada decorre do descompasso entre crescimento motivacional e maturidade regulatória.

O sofrimento atual é compatível com transição desenvolvimental e constitui janela estratégica para fortalecimento de competências.

O risco principal não é a intensidade emocional isolada, mas a possibilidade de consolidação de evitação. Com intervenção estruturada, o cenário mais provável é amadurecimento regulatório progressivo.

9. CONCLUSÃO EXECUTIVA

Este RAM conclui que:

- O momento atual não configura regressão estrutural;
- Há crescimento em curso acompanhado de vulnerabilidade transitória;
- O sistema familiar apresenta robustos fatores protetivos;
- A intervenção deve focar em competência e não apenas em contenção de crise.

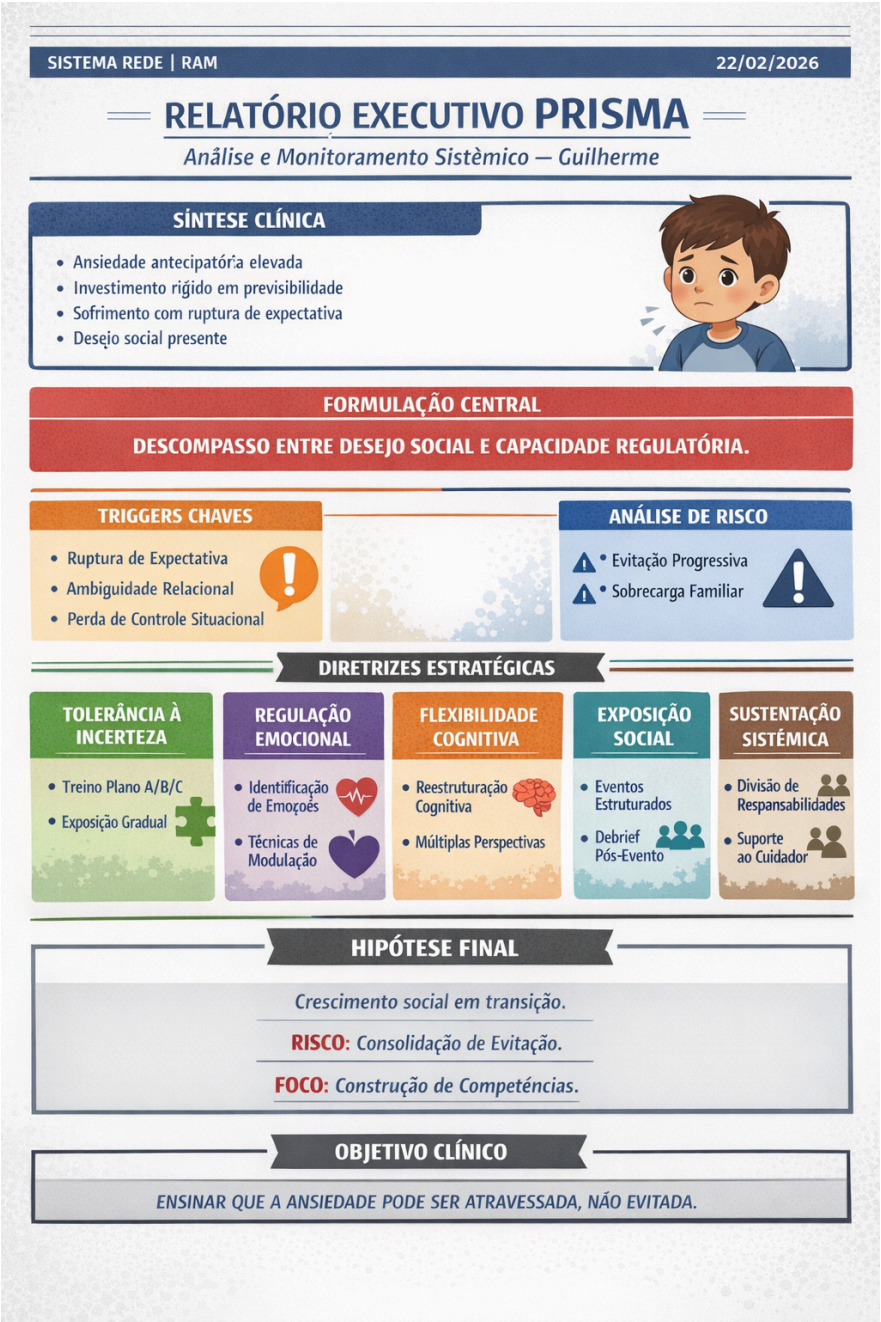
Objetivo clínico central: Ensinar que a ansiedade pode ser atravessada, não evitada.

O Sistema REDE recomenda monitoramento contínuo, intervenção estruturada e manutenção de exposição social graduada como estratégias prioritárias nos próximos meses.

SISTEMA REDE v3

REPORTE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO (RAM)

REFLEXÕES NINÁ (22/02/2026)



DOCUMENTO GERADO PELO PRISMA

lojinhadosautistas@gmail.com | @lojinhadosautistas